GUÍA PARA PROFESIONALES

Solo medicamentos con registro sanitario

Péptidos en sobrepeso y obesidad

Guía de manejo para el médico que prescribe: cómo funcionan, dosis, seguridad y uso.

Dr. Marco Sosa
Medicina Integrativa · Registro médico 050330



Estos péptidos imitan hormonas del intestino.

Semaglutida y liraglutida activan el receptor de GLP-1. Tirzepatida activa GLP-1 y GIP.

CÓMO FUNCIONAN

Tres efectos

Más saciedad

Actúan en el hipotálamo: menos apetito y menos antojos.

Estómago más lento

El vaciamiento gástrico tarda más: la llenura dura.

Insulina y glucagón

Más insulina si la glucosa está alta y menos glucagón.

Fuente: fichas oficiales de la FDA (Wegovy, Zepbound, Saxenda) y ensayos STEP 1, SURMOUNT-1 y SCALE.

SEGÚN EL DR. MARCO

GLP-1 y leptina trabajan juntos

En la obesidad

- Leptina alta, con resistencia
- Menos GLP-1
- El cerebro deja de sentir saciedad

Con análogos de GLP-1

- Se amplifica la señal de saciedad
- Se plantea mejor sensibilidad a la leptina
- Contrarrestan la señal de «hambruna» al bajar de peso

Fuente: presentación del Dr. Marco Sosa, diap. 51 a 59. La mejora de la sensibilidad a la leptina es una hipótesis.

PARA QUIÉN

Indicación

1	**IMC de 30 o más**	O de 27 o más con una enfermedad asociada.
2	**Con un plan**	Alimentación con menos calorías y más actividad física.
3	**Antes de indicar**	Historia, glucosa, HbA1c, lípidos, riñón, hígado y TSH.
4	**Antecedentes**	Revisar tiroides personal o familiar y medicamentos.

Fuente: fichas oficiales de la FDA (Wegovy, Zepbound, Saxenda) y ensayos STEP 1, SURMOUNT-1 y SCALE.

PANORAMA INTERNACIONAL

Qué dicen las agencias y las guías

OMS (dic. 2025)

Recomienda de forma condicional GLP-1 a largo plazo con IMC de 30 o más.

FDA

Semaglutida, tirzepatida y liraglutida con indicación para peso.

Unión Europea (EMA)

Mounjaro autorizado para peso; NAION: efecto muy raro de la semaglutida.

Reino Unido (NICE)

IMC de 35 o más con comorbilidad; semaglutida hasta 2 años.

Canadá, Japón y Australia

Wegovy y tirzepatida aprobados para obesidad.

Colombia

Confirmar el registro del INVIMA del producto exacto.

Fuentes: OMS 2025, FDA, EMA, NICE TA875 y TA1026, Health Canada, PMDA y TGA. Ver bibliografía.

RESULTADOS

Semaglutida en el ensayo STEP 1

≈15 %

pérdida media del peso a 68 semanas

- Con placebo: cerca de 2,4 %
- Adultos con obesidad y sin diabetes
- Al suspender, se recupera cerca de dos tercios en un año

Fuente: Wilding 2021 (PMID 33567185); extensión: Wilding 2022 (PMID 35441470).

RESULTADOS

Qué esperar según el medicamento

Semaglutida

Cerca de 15 % a 68 semanas (STEP 1).

Tirzepatida

Entre 15 % y 21 % a 72 semanas según la dosis (SURMOUNT-1).

Liraglutida

Cerca de 8 % a 56 semanas (SCALE).

Fuente: PMID 33567185, 35658024, 26132939.

1

Dosis

Según la ficha oficial.

SEMAGLUTIDA · INYECCIÓN SEMANAL

Escalada en 16 semanas

1	**Semanas 1 a 4**	0,25 mg
2	**Semanas 5 a 8**	0,5 mg
3	**Semanas 9 a 12**	1 mg
4	**Semanas 13 a 16**	1,7 mg
5	**Desde la 17**	2,4 mg (recomendada) o 1,7 mg

Fuente: ficha FDA de Wegovy.

TIRZEPATIDA · INYECCIÓN SEMANAL

Sube de 2,5 mg en 2,5 mg

Inicio

2,5 mg por 4 semanas (no es dosis de mantenimiento).

Subir

De 2,5 mg en 2,5 mg, tras al menos 4 semanas en cada dosis.

Mantenimiento

5, 10 o 15 mg semanales.

Máximo

15 mg una vez por semana.

Fuente: ficha FDA de Zepbound.

LIRAGLUTIDA · INYECCIÓN DIARIA

Escalada semanal

1	**Semana 1**	0,6 mg
2	**Semana 2**	1,2 mg
3	**Semana 3**	1,8 mg
4	**Semana 4**	2,4 mg
5	**Semana 5 en adelante**	3 mg diarios

Fuente: ficha FDA de Saxenda.

2

Otros péptidos

Retatrutida y el eje de la hormona de crecimiento.

RETATRUTIDA · EN INVESTIGACIÓN, SIN APROBACIÓN

Las dos formas de medir la pérdida de peso en TRIUMPH-4

Estimando de eficacia (titular)

- Solo quienes siguen el tratamiento
- 12 mg: –28,7 %
- 9 mg: –26,4 %
- Placebo: –2,1 %

Régimen de tratamiento (todos)

- Todos los participantes, sigan o no
- 12 mg: –23,7 %
- 9 mg: –20,0 %
- Placebo: –4,6 %

TRIUMPH-4: obesidad y artrosis de rodilla, 68 semanas, 9 y 12 mg semanales (se empieza con 2 mg). Resultados preliminares (HCPLive, Rheum Live). TRIUMPH-1, 80 semanas, régimen de tratamiento: 12 mg –25,0 %.

SEGURIDAD DE RETATRUTIDA

Lo que se ha visto en TRIUMPH-4

Digestivos

Náuseas en 38 % (9 mg) y 43 % (12 mg), frente a 10 % con placebo.

Sensibilidad de la piel

Disestesia en 9 % (9 mg) y 21 % (12 mg), frente a 0,7 %.

Suspensión

Por efectos adversos: 12 % (9 mg), 18 % (12 mg) y 4 % con placebo.

Fuente: TRIUMPH-4, reseñas de prensa médica; TRIUMPH-2 (PMID 42810372).

EJE DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO

Qué respaldan las fuentes oficiales

Tesamorelina

Aprobada solo para la grasa abdominal en VIH. La ficha dice que no es para manejar el peso.

Sermorelina y mecasermina

Uso pediátrico por déficit de GH o de IGF-1. No tratan la obesidad.

Secretagogos sin aprobación

No hay ensayos que respalden su uso en obesidad; pueden dar hambre.

Fuente: ficha FDA de Egrifta; Falutz 2007 (PMID 18057338); Prakash 1999 (PMID 18031173).

3

Seguridad

Contraindicaciones y precauciones.

CONTRAINDICACIONES

No usar si hay

Cáncer medular de tiroides

Antecedente personal o familiar.

MEN 2

Neoplasia endocrina múltiple tipo 2.

Alergia grave

Al medicamento o a sus componentes.

Fuente: fichas oficiales de la FDA (Wegovy, Zepbound, Saxenda) y ensayos STEP 1, SURMOUNT-1 y SCALE.

PRECAUCIONES

Se evalúan caso por caso

Páncreas y vesícula

Pancreatitis previa, cálculos.

Estómago

Gastroparesia grave: no se recomienda.

Riñón

Riesgo de deshidratación por vómito o diarrea.

Diabetes

Retinopatía; hipoglucemia con insulina o sulfonilureas.

Ánimo

Vigilar depresión e ideas de suicidio.

Embarazo y anestesia

Evitar embarazo; avisar antes de sedación.

Fuente: fichas oficiales de la FDA (Wegovy, Zepbound, Saxenda) y ensayos STEP 1, SURMOUNT-1 y SCALE.



Signos de alarma

Cuándo consultar o ir a urgencias.

PARA EL PACIENTE

Consulta o urgencias si presenta

Dolor fuerte de abdomen

Puede irse a la espalda: pancreatitis.

Dolor arriba a la derecha

Con fiebre o piel amarilla: vesícula.

Vómito o diarrea sin parar

Poca orina y mareo: deshidratación y riñón.

Cara o labios hinchados

Dificultad para respirar: alergia grave.

Bulto en el cuello

Dificultad para tragar o ronquera persistente.

Ánimo

Tristeza profunda o ideas de hacerse daño.

Fuente: fichas oficiales de la FDA (Wegovy, Zepbound, Saxenda) y ensayos STEP 1, SURMOUNT-1 y SCALE.

SEGÚN EL DR. MARCO

Cuatro fases del manejo

1. Preparación

Primera semana: valoración, contraindicaciones y hábitos base.

2. Intensificación

Unas 40 semanas: dosis baja y escalada; 1 a 2 kg por mes.

3. Transición

Unas 24 semanas: meseta y dosis de mantenimiento.

4. Mantenimiento

Largo plazo: seguimiento y hábitos; muchas veces se continúa.

Fuente: presentación del Dr. Marco Sosa, diap. 60 a 63.

PARA EL PACIENTE

Otras señales para consultar

Pérdida súbita de visión

Muy rara con semaglutida (EMA): consultar sin demora.

Hipoglucemia

Temblor, sudor frío, confusión, si usa insulina o sulfonilureas.

Pulso acelerado

Palpitaciones o latidos muy rápidos.

Embarazo o sospecha

Suspender y consultar al médico.

Fuentes: fichas FDA y comunicado del PRAC de la EMA.

Cuida el **músculo** mientras bajas de peso.

Proteína en cada comida y entrenamiento de fuerza. Es lo que recomienda el consenso europeo de 2026.

5

Recomendaciones de uso

Cómo usarlo bien.

RECOMENDACIONES

Seis claves

Receta y seguimiento

Solo productos con registro, en farmacias autorizadas.

Es un complemento

Plan alimentario y actividad física siempre.

Proteger el músculo

Proteína en cada comida y fuerza dos veces por semana.

Comer despacio

Porciones pequeñas, poca grasa y buena hidratación.

Titular con paciencia

No saltar pasos de dosis.

Pensar en el mantenimiento

Al suspender, el peso suele recuperarse.

Fuente: fichas oficiales de la FDA (Wegovy, Zepbound, Saxenda) y ensayos STEP 1, SURMOUNT-1 y SCALE.

CONCLUSIONES

Tres ideas para llevarte

1	**Registrados y con receta**	Semaglutida, liraglutida y tirzepatida.
2	**Titular y vigilar**	Subir despacio y conocer los signos de alarma.
3	**Enfermedad crónica**	Se acompaña con hábitos y se planea el mantenimiento.

Guía para el médico que prescribe

- Medicamentos de receta con registro sanitario
- Verificar siempre la ficha aprobada en el país
- Material educativo: no reemplaza la consulta

Las masterclasses son informativas y educativas. No constituyen diagnóstico, tratamiento ni prescripción personalizada, y no reemplazan la consulta médica. El Dr. Marco Sosa es Director Científico de Lumineight y percibe una participación sobre sus ventas; se declara para que lo tengas en cuenta al valorar lo que escuches.